ÉLIMINATION DU TÉTANOS MATERNEL ET NÉONATAL : À PROPOS D'UN ÉTAT DES LIEUX CHEZ LES PATIENTES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-BOGODOGO À OUAGADOUGOU

Nom du présentateur : Ouattara Adama

Auteurs et coauteurs : Sawadogo A, Ouedraogo E, Sawadogo Y A, Kiemtore S, Ouedraogo C

Affiliations : CHU-Bogodogo

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

INTRODUCTION 1/2

- initiative mondiale pour l'élimination du tétanos néonatal (TNN) a été lancée en 1989
- Rebaptisée en 1990 « élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN)» pour inclure le tétanos maternel (TM) .
- On entend par élimination du TNN la réduction chaque année à moins de 1 cas de TNN pour 1000 naissances vivantes dans chaque district.
- L'initiative = trois stratégies d'élimination :
  - Renforcement de la surveillance du TNN.
  - 80%vaccination des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer,
  - accouchements pratiqués dans de bonnes conditions d'hygiène, y compris des soins du cordon ombilical,

INTRODUCTION 2/2

- **Elimination TMN** : validée avec succès
  - BF (2012), RCI (2013)
  - Mali (2018), Nigéria, RDC et Tchad (2019)
- Dynamique actuelle=Eradication
- Depuis 2016: défi sécuritaire et humanitaire, accouchements hygiéniques
- CHU-Bogodogo: Centre de référence national
- But du travail: contribuer à l'élimination de la mortalité maternelle et périnatale

OBJECTIFS SPECIFIQUES 1/1

1. Décrire les caractéristiques sociodémographiques des accouchées
2. Evaluer le niveau de connaissances, des accouchées sur TMN
3. Déterminer les pratiques des accouchées sur le TMN
4. Analyser les facteurs associés aux pratiques des accouchées sur le TMN

METHODOLOGIE 1/4

- Cadre de l'étude

  - Service de Gynécologie et Obstétrique et médecine de la reproduction du CHU-B

- Type et période de l'étude

  - Etude descriptive et analytique transversale, collecte de données prospective du 15 décembre 2024 au 31 janvier 2025

METHODOLOGIE 2/4

- Population d'étude
  - Les femmes ayant accouchées récemment et admises au service de gynécologie-obstétrique durant la période d'étude
- Critères de sélection
  - Toutes les femmes ayant accouchées récemment et ayant donné leur consentement éclairé durant la période de l'étude

METHODOLOGIE 3/4

- Technique d'échantillonnage
  - Taille:189
  - Echantillonnage accidentel
- Collecte des données
  - Méthodes : Interviews ,Explorations documentaires, Observation des pratiques
  - Support : Entrevue, Carnet de santé, Observations des pratiques, Registre d'observation, Dossier des patientes

METHODOLOGIE 4/4

- Saisie et analyse des données

  - Epi info version 7.2.5.2; Word ET Excel 2019

  - Variables quantitatives : moyenne,
  - variables qualitatives : nombres et pourcentages.
  - Comparaison variables qualitatives : test du chi-carré ; test exact de Fisher ;
  - Comparaison variables quantitatives : test -t- de Student.

RESULTATS 1/10

❑ Caractéristiques sociodémographiques des parturientes

➡ Age

- Tranche âge [32-42[ans : **46,03%**

➡ Statut matrimonial

- Mariées : **79,89%**

➡ Profession

- Ménagère/FAF : **44,44%**
- Elève/Etudiantes : **16,40%**

RESULTATS 2/10

❑ Caractéristiques sociodémographiques des patientes

- Niveau d'instruction
  - Non scolarisées : **35,45%**
- Milieu de résidence
  - zone urbaine : **80,95%**
  - Zone rurale : **19,05%**
- Niveau socioéconomique
  - Bas : **65,61%**

RESULTATS 4/10

❑ Connaissances sur le TMN

➡ Connaissances et sources d'informations sur le TMN

- Connaisse le TMN : **80,95%**
- Source d'information(Personnel de santé) : **82,35%**

➡ Evaluation du niveau de connaissance du TMN

- Non satisfaisant (insuffisant) : **88,36%**
- satisfaisant (moyen) : **10,05%**

RESULTATS 5/10

❑ Connaissances sur le TMN

- Recommandations du PEV
  - Non connu : **65,95%**

- Connaissance de la gratuité du VAT au BF
  - Oui : **93,65%**

- Evaluation du niveau de connaissance sur le VAT
  - Non satisfaisant (insuffisant) : **83,60%**
  - satisfaisant (moyen) : **13,75%**

RESULTATS 6/10

❑ Connaissances sur le TMN

- Connaissances des risques liés à l'absence de vaccination
  - Connu : **75,13%**

- Connaissances d'autres mesures de prévention
  - Connu : **25,40%**
  - Hygiène rigoureuse pendant l'accouchement et couper le cordon ombilical avec instruments stériles : **89,58%**

RESULTATS 7/10

❑ Pratiques liées à l'éradication du TMN

➡ Appréciation du Support de consultations

- Femmes possédant un carnet de vaccination : **100%**
- Nombre de doses enregistrés ≥ 3 doses : **51,01%**
- Primipares à jour : **91,50%**
- Pauci pares à jour : **54,10%**

RESULTATS 8/10

❑ Pratiques liées à l'éradication du TMN

➡ Evaluation des objectifs spécifiques de l'OMS

- Intervalles appropriés (80%,OMS) : **38,09%**
- Bonne pratiques liées VAT : **94,71%**
- Bonnes pratiques liées aux conditions d'accht : **100%**
- Bonnes pratiques globales : **100%**

RESULTATS 9/10

- **Facteurs associés aux pratiques des patientes sur l'éradication du TMN**

➡ Facteurs associés aux mauvaises pratiques

- Niveau socioéconomique bas : ***p* = 0,041**
- Non scolarisation : ***p* = 0,005**
- Primiparité : ***p* = 0,001**
- Primigeste : ***p* = 0,001**

RESULTATS 10/10

- **Facteurs associés aux pratiques des patientes sur l'éradication du TMN**

➡ Facteurs liés au conjoint associés aux mauvaises pratiques

- Niveau étude primaire : ***p* = 0,006**

Conclusion

- Faible taux de vaccination et Lacunes persistantes : importance de la VAT et pratiques d'hygiène essentielles
- Renforcer campagnes d'éducation et communication ; guider politiques publiques vers approche plus ciblée et efficace

Merci pour votre attention